

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Martin Weber geb.: 25.04.1954 ID: STT-PCA-0825-002 Fall-ID: FALL-PCA-02

Datum der Untersuchung:

08.08.2025

Tumornachsorgekalender-Nr:**ausgestellt am:**

08.08.2025

Überweiser:

Urologie Sankt Josef

Primärdiagnose:

04/2025

Primärtumor:

C61 - Bösartige Neubildung der Prostata, diagnostiziert 08.2025 (Aktiv)

Histologie des Primärtumors:

Adenokarzinom Gleason 9

TNM bei Erstdiagnose:**aktuelle Lokalisation:
(z.B. Metastase/Rezidiv)**

Primarius + paraaortale und links iliakale Lymphknoten

TNM-Stadium:

IV

THERAPIEVERLAUF: (Zeitraum, Schema + Zyklen bzw. Dosis bei Radiatio)

04/2025: Erstdiagnose bei initialem PSA von 279,0 ng/ml. Stanzbiopsie mit Nachweis eines klinischen N1-Prostatakarzinoms in 10 von 10 Stenzen.
16.05.2025: CT-Abdomen mit Nachweis paraaortal und interaortokaval gelegener sowie links parailiakaler Lymphknotenmetastasen.
Empfehlung der interdisziplinären Tumorkonferenz: Prüfung Studieneinschluss, alternativ ADT + Docetaxel + Darolutamid versus Apalutamid versus Enzalutamid. Bei Oligometastasierung Radiatio des Primarius.

ALLGEMEINANAMNESE: (Familienanamnese, Risikofaktoren, Vorerkrankungen, Operationen, usw.)

Adipositas.

Allergien:**Allergien:**☐ ja☒ nein**Port/PEG:**☐ ja☒ nein**Schrittmacher:**☐ ja☒ nein**Betreuung:**☐ ja☒ nein**TUMORANAMNESE/aktuelle Beschwerden:**

Nykturie und Dysurie, im Übrigen keine relevanten Beschwerden.

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Martin Weber geb.: 25.04.1954 ID: STT-PCA-0825-002 Fall-ID: FALL-PCA-02

STT-Verordnung vom: 08.08.2025 Patient/in: Martin Weber ID: STT-PCA-0825-002

AKTUELLER STATUS:**Karnofsky-Index:**

90% - Normal, nur geringfügige
Anzeichen/Symptome. (Karnofsky)

Größe:

174 cm

Gewicht:

93 kg

Patient mobil selbstständig, keine peripheren Ödeme, reguläre körperliche Belastbarkeit. Abdomen weich, kein Druckschmerz, keine Abwehrspannung, inguinal keine pathologischen Lymphknoten palpabel.

BESTRAHLUNGSVERORDNUNG:

Begründung der Strahlentherapie - Indikation:

☒ kurativ☐ palliativ☐ gutartig

Zielvolumen und Dosierung:

Lokal Prostata incl. Samenblasen
2,0 Gy bis 60,0 Gy
Boost bis 74,0 Gy

Simultane Systemtherapie:

nein ; X ja, ADT + Darolutamid + Docetaxel über Sankt Josef

Vorbestrahlung
(wann/Lokalisation/Dosis):

X nein ; ja,

☒ Kontakt SozDienst besprochen/Infoblatt ausgehändigt**ausgebender Arzt:**

Dr. Tim Schuster

auswärtige Bildgebung:☒ eingelesen:**Bestrahlungsgerät:**☐ L1☐ L2☒ L3☐ AL/Intrabeam**Termine:**

Planungs-CT / Maske / Markierung:

13.08.2025 10:00 Uhr

Ersteinstellung:

26.08.2025 11:00 Uhr

Labor vor Chemo:

Tagesklinik:

Station:

Sonstiges:

Datum: 08.08.2025 14:32:50**erstellender Arzt:**

Dr. Felix Reimann

Datum: 08.08.2025 16:15:50**F-/O-Arzt:**

Dr. Tim Schuster

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Martin Weber geb.: 25.04.1954 ID: STT-PCA-0825-002 Fall-ID: FALL-PCA-02

CT-Anordnung vom:

08.08.2025

Anordnender Arzt:

Dr. Felix Reimann

DIAGNOSE:

Primär C61 - Bösartige Neubildung der Prostata, diagnostiziert 08.2025 (Aktiv)

Behandlungsindikation:

Prostata + Samenblasen primär

**LAGERUNGS- UND SCANVORGABE:
REGION:**☐ Schädel ☐ Hals ☐ Thorax ☐ Abdomen ☒ Becken ☐ 4D-Atemstudie ☐ DIBH☐ Spezielle Anforderung Region:☐ bei Erreichen einer GHD von

Gy

☐ am:☐ Extremitäten:☐ Ganzkörper-CT:☐ bitte Arzt hinzurufen

(Soll ein Flap aufgelegt werden, z. B. Basaliom Kopfregion, muss der Flap durch den Ambulanzzarzt VOR dem Planungs-CT aufgelegt werden. Bei Basaliom Nasen-/Ohrregion bitte statt Flap Planungs-CT mit Moulage.)

Lagerung:

☐ Bauchlage	☐ Belly step
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: auf Brust	☐ Knee step
☐ Maske	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung
☐ Wing step	☐ Anusmarkierung
☐ Knierolle	☐ Drahtmarkierung
☒ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen	☐ Bellyboard

Datum: 08.08.2025 14:35:12**erstellender Arzt:**

Dr. Felix Reimann

Datum: 08.08.2025 16:17:06**F-/O-Arzt:**

Dr. Tim Schuster

Die Planungs-CT ist Bestandteil der Bestrahlungsplanung und der dazugehörigen Patientenaufklärung.

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Martin Weber geb.: 25.04.1954 ID: STT-PCA-0825-002 Fall-ID: FALL-PCA-02

Datum der Untersuchung: 13.08.2025

Gewicht Patient:

93 kg

Ganzkörper-CT:

☐ Patientendurchmesser < 30 cm

☐ Patientendurchmesser > 30 cm (Probeliegen bei Erstgespräch)

Referenzpunkt:

Tischhöhe:

14 cm

Lagerung:

☐ Bauchlage	☐ Belly step
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: auf Brust	☐ Knee step
☐ Maske	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung
☐ Wing step / Ring	☐ Anusmarkierung
☐ Knierolle	☐ Drahtmarkierung
☒ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen	☐ blaue Matte
☐ Bauchpresse	☐ 4D-Atemstudie
☐ schiefe Ebene	☐ Bellyboard
☐ DIBH	
☐ Name Atemkurve	

Beckenlagerung für Prostata + Samenblasen. Blasen-/Rektumfüllung nach Hausstandard kontrollieren.

Nach Durchführung der CT verpflichtende Kontrolle (DA)

kontrolliert:

1. Wirbelsäule optisch und im Scout gerade gelagert?
Keine metallischen Lagerungshilfen im Bild?

☒

2. Ref-Markierung (Bleikugeln) im CT-Schnitt auf einer Schicht?

☒

3. Blasen-/Rektumfüllung kontrolliert?

☒

4. KM-Reste Darm/Blase -> Arzt dazu

☐

5. Ganzer Patientenumfang wird rekonstruiert?

☒

6. Bei Kontroll-CT: Was wurde mit Bleikugeln markiert?

☐

Datum: 13.08.2025 10:18:00

MTRA: Nina Hartmann

Datum: 13.08.2025 10:41:00

F-/O-Arzt: Dr. Laura Mertens